Santé publique · 7 septembre 2026

Stratégie nationale de santé sexuelle 2026-2030 : le texte intégral du ministère

Sur les 22 actions du plan, deux touchent les laboratoires : le déploiement de la biologie délocalisée à partir de 2027, et l'optimisation du dispositif « Mon test IST », dont le calendrier court jusqu'en 2028.

Le ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées a mis en ligne le 7 septembre 2026 le texte intégral de la feuille de route 2026-2030 de la stratégie nationale de santé sexuelle. Le document de 72 pages détaille, pour chacune des 22 actions, le contexte, les objectifs, les pilotes, les jalons annuels et les livrables attendus.

Deux actions concernent directement les laboratoires de biologie médicale. L'action n° 6, pilotée par la Direction générale de la santé (DGS) et la Haute Autorité de Santé (HAS), vise à améliorer les stratégies de dépistage du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des hépatites virales : le document rappelle qu'en 2024, 43 % des infections au VIH ont été découvertes à un stade tardif et que près de 10 000 personnes ignorent leur séropositivité. Il prévoit le déploiement de la biologie médicale délocalisée, définie comme un examen dont la phase analytique est réalisée en dehors du laboratoire, ainsi que des autoprélèvements et des tests sur sang séché, avec un lancement des travaux en 2026, un déploiement en 2027 et une évaluation en 2028.

L'action n° 7 porte sur le dispositif « Mon test IST », qui permet depuis le 1er septembre 2024 le dépistage sans ordonnance de la chlamydia, du gonocoque, de l'hépatite B et de la syphilis dans l'ensemble des laboratoires de biologie médicale, en complément du dépistage du VIH sans ordonnance en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Le document indique que 8,5 millions de sérologies de dépistage du VIH ont été réalisées en 2024 et fixe le calendrier suivant :

– 2026 : analyse quantitative du recours au dépistage sans ordonnance à partir des données du Système national des données de santé (SNDS) ;
– 2027 : évaluation coût-efficacité et publication des recommandations d'évolution du dispositif ;
– 2028 : mise en œuvre des évolutions réglementaires d'optimisation du dispositif.

Les actions n° 10 (prophylaxie pré-exposition à longue durée d'action et traitement post-exposition au VIH) et n° 13 (continuum de prise en soins des hépatites virales, avec un objectif d'élimination à l'horizon 2030) complètent ce volet dépistage et prévention.

> Document joint : la feuille de route 2026-2030 (ministère de la Santé, 72 pages). Il s'ouvre depuis la page Actualités du site du SLBC.